

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



«Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο».

«Υγεία και μυαλό είναι δυο θαυμαστά πράγματα στη ζωή».

Μένανδρος, 4^{ος} αιώνας π.Χ.

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Γενικά: Ως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (AEE - Stroke/CVA) περιγράφεται κάθε ταχέως αναπτυσσόμενο κλινικό σύνδρομο, το οποίο οδηγεί σε εστιακή ή γενικευμένη απώλεια της εγκεφαλικής λειτουργίας, για περισσότερο από 24 ώρες, αγγειακής και μόνον αιτιολογίας. Σχεδιάζουμε τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ενός ασθενούς με AEE, ανάλογα τι υποψιαζόμαστε, ήτοι ισχαιμικό, αιμορραγικό AEE ή TIA (*Transient Ischaemic Attack*). Η κλινική εξέταση παρέχει πληροφορίες για τον τύπο του AEE, αλλά την τελική διάγνωση θέτει η CT ή η MRI εγκεφάλου. Με την ενδελεχή κλινική εξέταση, επίσης, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες για την εντόπιση του AEE (σύστημα καρωτίδων ή σπονδυλοβασικό).

Κλινική εικόνα: Από το **σύστημα των καρωτίδων**, τα σημεία και συμπτώματα, είναι: Θάμβος - αμαύρωση πεδίου του ενός οφθαλμού, αδυναμία - υπαισθησία ενός κάτω άκρου, αδυναμία - υπαισθησία ημιπροσώπου και του ομόπλευρου άνω άκρου, δυσαρθρία, αφασία. Από το **σπονδυλοβασικό σύστημα**, τα σημεία και συμπτώματα, μπορεί να είναι: Ίλιγγος, διπλωπία, δυσκαταποσία, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης ή συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων από τα προηγούμενα με ημιπάρεση και υπαισθησία.

Το παροδικό AEE (TIA - Transient Ischaemic Attack), εμφανίζεται εν αιθρία, σαν ένα αιφνίδιο, σύντομο επεισόδιο νευρολογικής δυσλειτουργίας, το οποίο προκαλείται κυρίως από εστιακή εγκεφαλική ή αμφιβληστροειδική ισχαιμία, με κλινικά συμπτώματα συνήθους διάρκειας < 60 λεπτών, που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε οξύ εγκεφαλικό έμφρακτο. Θεωρείται πλέον ότι το TIA μπορεί να προκαλέσει αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη, παρ' όλα αυτά το 60% των περιπτώσεων συνοδεύονται από ευρήματα στην αξονική τομογραφία.

Το θρομβοεμβολικό ή ισχαιμικό AEE (80%), είναι συνηθέστερο σε μεγάλες ηλικίες. Μπορεί να εμφανιστεί με ήπια κλινικά συμπτώματα και σημεία, όπως κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγο, ναυτία, έμετο, αστάθεια, δυσαρθρία, πνιγμονή από δυσκαταποσία υγρών, κ.λπ. Ενίοτε, η κλινική εικόνα ενός I-AEE είναι βαριά, με απώλεια συνείδησης, λήθαργο/κόμα, αφασία μεικτού τύπου, τονικοκλονικούς σπασμούς ή status epilepticus.

Τα Αιμορραγικά AEE [ενδοεγκεφαλικές & υπαραχνοειδείς αιμορραγίες (20%)], συνήθως αφορούν ηλικίες 40-60 ετών. Τα A-AEE παρουσιάζονται ενίοτε με απώλεια συνείδησης, ανισοκορία, απόκλιση ή στροφή των οφθαλμών ρινικά ή κροταφικά, απώλεια ούρων και κοπράνων και επιληπτικές κρίσεις. Ο ασθενής, αρκετά συχνά, μπορεί να αναφέρει αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία, μερικά λεπτά προ του επεισοδίου έως και ώρες πριν από αυτό.

Ιστορικό: Έλεγχος των παραγόντων κινδύνου (κολπική μαρμαρυγή). Λήψη αντιπηκτικών. Συνυπάρχουσα νοσολογία (λοιμώξη, τραύμα, ΚΕΚ, χειροπρακτική της ΑΜΣΣ, ημικρανία) ή συστηματικό νόσημα. Νεότεροι ασθενείς ελέγχονται για χρήση ουσιών ή αντισυλληπτικών. Έλεγχος για απορρύθμιση της ΑΠ. Αξιολόγηση ενδείξεων για πιθανή διόρθωση της ΑΥ.

Αδρή νευρολογική εκτίμηση: Κινητικότητα και αισθητικότητα, έλεγχος κορών οφθαλμών, αντανakλαστικό Babinski, αντανakλαστικό κερατοειδούς, λοιπά αντανakλαστικά άμφω. Το επίπεδο συνείδησης εκτιμάται άριστα με την κλίμακα κώματος Γλασκώβης (GCS).

Προνοσοκομειακά, επιχειρείται μια πρώτη εκτίμηση του AEE με την **Κλίμακα Cincinnati**. Η κλίμακα εξετάζει τη φυσιολογική ή παθολογική απάντηση σε 3 κλινικές παραμέτρους:

1. Εξέταση για πάρεση του προσωπικού νεύρου (παραγγέλλεται στον ασθενή να χαμογελάσει και να δείξει τα δόντια του και ελέγχουμε τη συμμετρία της έκφρασης του προσώπου).
2. Εξέταση για αδυναμία και πάρεση των άνω άκρων (με κλειστά μάτια, ο ασθενής καλείται να σηκώσει τα χέρια του ταυτόχρονα και να τα διατηρήσει τεντωμένα ισότιμα).
3. Εξέταση για τον έλεγχο της ομιλίας (δίδεται στον ασθενή εντολή να πει μία πρόταση και ελέγχεται η αδυναμία εκφοράς, η δυσχέρεια άρθρωσης, η χρήση άλλων λέξεων, κ.ά.).

Αν έστω μία παράμετρος από τις παραπάνω κρίνεται ως παθολογική, τότε η πιθανότητα να έχει ο ασθενής AEE είναι ~72%. Αν περισσότερες από μία παράμετροι είναι παθολογικές, τότε η πιθανότητα η παρούσα νευρολογική διαταραχή να αφορά AEE υπερβαίνει το 85%.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Μεριμνούμε, πρωτίστως, για τον έλεγχο των A, B, C, D, E, εφόσον ο ασθενής βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση. Εξασφαλίζουμε τον αεραγωγό και αερίζουμε τον ασθενή. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, Θ). Διενεργούμε ΗΚΓ. Λήψη γενικής αίματος, B/X έλεγχο (Glu, Urea, Creat., K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, INR/aPTT, κ.ά.), αέρια αίματος.
2. Χορηγούμε O₂ με ροή στα 4-8 l/min, με στόχο να διατηρούμε το SpO₂ > 90-92%.
3. Τοποθετούμε 3way φλεβική γραμμή με 500-1000 ml N/S ή R/L, βραδέως (40-80 ml/h).

Ουδέποτε τοποθετείται ορός D/W 5% (διότι η γλυκόζη επιδεινώνει πιθανή εγκεφαλική ισχαιμία). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που ο ασθενής έχει σοβαρή υπογλυκαιμία οπότε αυτή ανατάσσεται με τη χορήγηση διαλύματος γλυκόζης [1-3 amp. 10 ml D/W 35% (με επιθυμητά επίπεδα γλυκόζης: 90-150 mg/dl)], ή επί σοβαρής αρτηριακής υπέρτασης δηλ. ΣΑΠ/ΔΑΠ ≥ 220/110 mmHg, οπότε προσθέτουμε παράλληλα σε 3way και 250 ml D₅W με 1 amp. Nitrolingual 25 mg, με στόχο να μειώσουμε σταδιακά τη ΣΑΠ ≈ 170-180 mmHg.

4. Εναλλακτικά, αντί των Νιτρωδών (NTG) για την ελάττωση της ΑΠ, μπορεί να χορηγηθεί **Κλονιδίνη** ή **Λαβεταλόλη** (εφόσον δεν υπάρχει σοβαρή αντένδειξη για β-blocker), ήτοι:
 - ▶ 1-3 amp. Catapres, εντός 250 ml N/S, με χρόνο ροής 20-60 λεπτά, αναλόγως της ΑΠ.
 - ▶ 20-50 mg (4-10 ml, amp. 100 mg) Trandate, εντός 100 ml N/S, σε χρόνο 10-30 λεπτά.

Δεν επιχειρείται η μείωση των υψηλών επιπέδων της ΑΠ – τις πρώτες ώρες ή 24ωρα – σε έναν υπερτασικό ασθενή με ΑΕΕ, εκτός και αν πρόκειται για οξύ αιμορραγικό ΑΕΕ, υπαραχνοειδή αιμορραγία ή αν υπάρχει σοβαρή εμμένουσα υπέρταση ή άλλες συνοδές επείγουσες καταστάσεις (π.χ. OEM, Αορτικός Διαχωρισμός, Υπερτασική Εγκεφαλοπάθεια) ή στην περίπτωση που προγραμματίζεται θρομβόλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στόχος είναι η επίτευξη ΜΑΠ ≈ 90-100 mmHg, για τη διατήρηση της αιμάτωσης πέριξ της βλάβης, στη «Λυκοφωτική Ζώνη - Penumbra». Υπενθυμίζεται ότι: $ΜΑΠ = [ΣΑΠ + (ΔΑΠ \times 2)] / 3$.

5. Χορηγούμε **γαστροπροστασία**, με Σιμετιδίνη (1-2 amp. Tagamet) ή/και 1 amp. PPI (iv).
6. Χορηγούμε **Μετοκλοπραμίδη** (1 amp. Primperan 10 mg, iv) ή 1 amp. Onda 8 mg, για την πρόληψη του εμέτου (σύνηθες κατά τις διακομιδές ασθενών) και πιθανής εισρόφησης.
7. Τοποθετούμε **ρινογαστρικό σωλήνα Levin**, για την αποσυμφόρηση του στομάχου ή για την αποφυγή εισρόφησης και για την πιθανότητα έναρξης σίτισης μετά από 48 ώρες.
8. Τοποθετείται **ουροκαθετήρας Foley** για κένωση της κύστης (η γεμάτη ουροδόχος κύστη είναι πιθανός παράγοντας αύξησης της ΑΠ) και για τη μέτρηση του ισοζυγίου υγρών.
9. Εφόσον ο ασθενής είναι διεγερτικός, χορηγείται 1 amp. Διαζεπάμη (Stedon) 10 mg εντός 100 ml N/S (iv-στάγδην) ή εναλλακτικά 1 amp. Aloperidin (im) ή 1 amp. Zuledin (im).
10. Επί επιληπτικής κρίσης χορηγούμε 1 amp. Diazepam (Stedon) 10 mg σε 100 ml N/S (iv). Αν οι σπασμοί επιμένουν χορηγούνται 3-5 amp. Epanutin των 250 mg σε 500 ml N/S, με ρυθμό έγχυσης 10-30 mg/min (σε 40-60 λεπτά). Εναλλακτικά, Λεβετιρακετάμη (Keppra) σε δόση: 60 mg/kg, (max: 4500 mg), εντός 100 ml N/S, με χρόνο έγχυσης 10-15 λεπτά.
11. Επί κλινικής υποψίας ή επί διαγνώσεως - με CT ή MRI - αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και εγκεφαλικού οιδήματος ή εφόσον υπάρχει γνωστό ιστορικό ενδοκράνιας εξεργασίας, χορηγούμε 1 amp. Dexamethasone 8 mg (Decadron) iv ή im (αν και η αναγκαιότητά της, στην οξεία φάση ενός ΑΕΕ, ακόμα και επί αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης, αμφισβητείται).
12. Επί διάγνωσης βαριάς **Υπαραχνοειδούς Αιμορραγίας** ή **Αιμορραγικού ΑΕΕ**, η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε επίπεδα ΑΠ ≈ 180/110 mmHg, οπότε χορηγείται ενδοφλεβίως **Νιμοδιπίνη**, ήτοι 1 fl. Nomotop 10 mg/50 ml, σε αργή στάγδην έγχυση (1-2 mg/h ~ ΑΠ). Η Νιμοδιπίνη αναστέλλει τη μεταφορά των ιόντων ασβεστίου στα κύτταρα των αγγείων και συνεπώς αναστέλλει τις συσπάσεις του αγγειακού λείου μυϊκού ιστού.
13. Άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεύει ιατρού, με τον ασθενή στο ασθενοφόρο με υπερυψωμένη την κεφαλή του σε κλίση γωνίας 30°. Συνιστάται η **άμεση θρομβόλυση** (επί ενδείξεων) εντός 3-4,5 ωρών από την εγκατάσταση ισχαιμικού ΑΕΕ και η νοσηλεία όλων των ασθενών με ΑΕΕ σε ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης ΑΕΕ (Stroke Units).